

14. 두통

● 중요 포인트

- 이차성 두통인지의 감별이 중요
- 일차성 두통이더라도 이차성일 가능성을 열어두고 진단/치료/응급에 대해 교육 해야함
- 일차성 두통의 임상양상들을 잘 알아두자

● 평가 목표

원인		
일차 두통		긴장형 두통, 편두통
이차성 두통	두경부 질환	뇌졸중, 염증성질환
	이외	약물, 감염성 질환
평가목표		
1) 일차두통과 이차두통을 구별		
2) 이차두통 감별을 위한 적절한 진단계획과 일차두통의 치료계획을 수립		
3) 특히 응급치료가 필요한 환자를 감별		
구체적인 성과		
병력 청취	두통의 구체적 양상 파악	기간, 정도, 환자가 느끼는 양상
	일차두통의 특징적 임상 양상	통증의 양상 파악/지속시간/위치
	이차두통의 주요 동반 증상	전신증상(발열,오한,체중감소)/신경계증상(팔다리힘빠짐, 마비, 구음장애)
신체 진찰	신경계 이상을 확인하기 위한 신경 진찰	뇌신경검사/소뇌검사/상하지 운동,감각,DTR/수막자극징후
	원인 감별을 위한 신체진찰	눈-입-목-사지
진단	일차두통과 이차두통의 감별	혈액검사 + 뇌 영상검사를 통해 기질적 원인이 있는지 확인 + 크롬친화세포종(복부 영상검사)
	위중한 혹은 응급을 요하는 원인에 의한 두통 구별	*red flag sign -전신 증상 동반 (체중감소, 심한 발열) -신경학적 증상 동반 (팔다리 힘빠짐, 편측 마비, 구음장애, 의식저하) -이제까지 경험해보지 못한, 갑작스럽게 발생한 심한 두통 -특정 자세에서 심해지거나, 완화되는 두통 -50 세 이후에 새롭게 발생한, 혹은 점점 심해지는 두통
치료	일차두통의 치료계획	진통제 + 예방 약물 치료 + 생활습관개선
	응급치료가 필요한 환자 감별 및 치료계획 수립	뇌수막염(항생제, 항바이러스제, 스테로이드) / 뇌출혈(항고혈압제, 뇌동맥류 지혈, 코일 시술, 필요시 감압개두술) / 뇌종양 (수술, 항암, 방사선)
환자 교육	일차두통과 만성두통의 관리 교육	진통제 교육, 유발 요인 피하기
	신속한 진단 혹은 응급치료가 필요한 두통을 설명	Red flag sign 에 해당하는 증상 발생시 병원 오라고 교육

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
일차성	편두통 3+0	뇌 혈관이 민감해져서 생기는 통증	L: 일측성 D: 4~72 시간 지속 C: 박동성 A: 전조증상 동반 가능 (시각 증상) F: 활동, 빛, 소리에 악화	-	-	약물치료(NSAID, 트립탄) + 예방적 약물치료 (BB)
	긴장성 두통 1+1	스트레스나 피로로 머리 주변 근육이 팽 조여지면서 발생하는 '신경성 두통'	L: 양측성 D: 지속시간 다양 (30min ~7 시간) C: 조이는 듯한, 뒷목 뻣근(근육 긴장)	-	-	목 스트레칭 진통제 스트레스 관리 마사지 명상
	군발 두통 0+1	우리 몸의 생체 시계를 조절하는 뇌 부위가 과하게 활성화되면서, 눈 주변 신경과 혈관을 자극해 마치 송곳으로 찌르는 듯한 극심한 통증을 일으키는 질환	환자가 남자(90%) D: 15min ~ 3 시간, 주기적으로 나타남, 하루 중 특정 시간대 A: 눈물, 콧물, 안구통증 F: 특정 계절에 나타나는 경향 있음		-	급성기: 산소치료 예방적 약물치료(sumatriptan)
	삼차신경 통	얼굴의 감각을 담당하는 신경이 눌려, 세수나 양치질만 해도 전기 오듯 번쩍이는 통증	C: 강한 전기가 흐르는 듯한 심한 통증 L: 편측성 D: 하루에 수십회까지 반복 A: 조금만 얼굴 건드려도 아픔(통증 유발점 존재)	유발점 확인	-	항경련제, 필요시 수술
이차성	거미막밑 출혈	뇌혈관이 터져 뇌막 사이에 피가 고인 상태로, 즉시 수술적 처치가 필요	갑자기 발생, 이전에 경험해보지 못한 극심한 두통, 오심 구토, 의식저하, 고혈압/뇌동맥류 Hx.	국소신경학적 이상	뇌 CT 뇌척수액 검사 뇌혈관조영술	산소공급 혈압 조절 혈관내시술 동맥류 결찰 시술
	대상포진		날카롭게 찌르는 통증 양상	Td		Acyclovir
	뇌내출혈	고혈압 등으로 뇌 안의 혈관이 터져 뇌 조직이 손상	갑작스러운 두통 및 국소신경학적 결손(편마비, 시야이상, 언어장애), 고혈압 Hx	국소신경학적 이상	뇌 CT/MRI 뇌혈관조영술	혈압 조절, 뇌압 조절, 필요시 뇌감압술
	뇌종양 0+1	뇌 안에 혹이 생겨 뇌압이 높아진 상태	잠에서 깰 정도의 두통, 체중 감소, 구역/구토, 경련, 의식 변화, 체중감소, 암 Hx	국소신경학적 이상	뇌 CT/MRI	수술 항암치료 방사선
	뇌수막염	뇌를 싸고 있는 막에 세균이나 바이러스가 침투해 염증 발생	발열 오한 구토	수막자극징후	뇌 CT 뇌척수액 검사	항생제 스테로이드
	측두동맥염	관자놀이 혈관에 염증이 생긴 것	관자놀이 주변 두통, 전신 증상(발열, 근육통), 식사 시 턱관절 통증	압통, 동맥이 딱딱하게 만져지기도 함	혈액검사(염증 수치) 측두동맥 US	고용량 스테로이드
	약물 과용 두통	두통약을 너무 자주 복용해서 오히려 뇌의 통증 감각이 예민해져 발생하는 두통	만성적 두통, 진통제 Hx 편두통 증상 동반 가능	-	-	약물중단 약물 남용 교육 안심
	외상 후 두통	교통사고나 낙상처럼 머리에 충격을 받은 이후, 뇌가 예민해져서 발생하는 두통	머리 다친 Hx	-	뇌 CT/MRI	혈압 조절, 뇌압 조절, 필요시 뇌감압술
	크롬세포	부신이라는 기관에 혹이	두통, 두근거림, 발한,	-	소변	알파차단제 후

	진화중	생겨 혈압을 높이는 호르몬이 과다 분비되면서 두통과 두근거림이 나타남	식은땀, 불안		메타네프린 복부 CT	부신절제술
	경추성 두통 0+1	목뼈(경추)의 배열이나 근육 문제로 인해 머리 뒤쪽까지 통증이 전달되는 증상				

O	언제 갑/서 상황: 주로 어떤 상황에서 머리가 아프세요?
L	머리 어디? 짚어주시겠어요? (편측인지, 국소적인지 확인) 다른 부위로 통증이 퍼지나요? (뻗치는지) 그외 아픈곳
D	개방형 지속시간 빈도 주기적으로 아팠다 안 아팠다 하나요 -r/o 군발성두통 하루 중 어느 시간 -아침:편두통/오후:긴장성 두통
Co	점점 심해지나요
Ex	이전 경험 - 치료(진통제-얼마나 먹어요?)
C	어떤식으로 아픈가요? 전기 통하듯이(삼차 신경통)/찌를 두르듯이(긴장성 두통)/육신육신(편두통)/깨질 듯이(뇌출혈) 정도) NRS, 일상생활 지장
A	개방형: “다른 불편한 곳은 없으세요? 네. 그럼 제가 몇가지 자세하게 확인해보겠습니다.” [전신] 발열/오한/체중변화/피로/식욕부진 [신경] 두통/팔다리 힘빠짐/목 뻣뻣/경련 [편두통] 전 - 눈 앞 반짝/물체 잘 안보임/구역/구토 중 - 구역/구토 [군발두통] 눈물/콧물/안구통증 [삼차 신경통] 얼굴 통증 (예시 들어서-양치,세수,면도) [크롬친화세종] 두근거림/발한
F	개방형: “증상이 어떨 때 좀 괜찮아지고/심해지나요?” *시계운동감자소스 시간(편두통, 긴장성)/계절(군발)/운동(뇌압)/감기증상(뇌수막염)/자세/소리빛/스트레스 빛, 소리 (밝고 시끄러운 장소) 스트레스 운동 - 배변/과한 활동 -r/o 뇌압상승으로 인한 두통 자세 -r/o 이차성 두통
E	건강검진
외	외상 - 머리 다친 적 수술 - 머리 수술
과	기저질환 (HTN/DL/DM/Tb/Hep) 뇌졸중 발작
약	복용 중인 약물
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/식습관/운동 커피: 얼마나 먹는지/먹다 안먹다 하는지 수면: 수면 시간/규칙적인 수면 직업: 스트레스/근무할 때/거북목 자세?
가	비슷한 증상 편두통 만성질환-고혈압

	심뇌혈관질환-심근경색, 뇌졸중		
여	월경 주기와 연관성- 월경 주기에 따라 두통이 생겼다 없어졌다가 하나요?		
PEx	동의 구하기, 손 씻기 v/s 확인-눈-입-목-사지-뇌신경-소뇌-팔다리(감각/운동/DTR)-수막자극징후		
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 아프다는곳 눌러보기? 압통점 확인 r/o 측두동맥염, 대상포진 2 눈: 빈혈, 황달 3 입: 탈수 4 목: 경부 림프절 + 갑상샘 5 사지 : 피부 긴장도, 다리부종 6 뇌신경 (동공 반사/안구 운동/얼굴 감각/얼굴 운동) 7 보행 (침대까지 걸어가보세요) 8 (침대에 앉혀서) 상하지 감각/운동/DTR 9 (눕혀서) 바빈스키 10 수막 자극 징후 + 안저검사	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
진단 치료 교육	기본		혈액검사 (염증 수치) + 영상검사 (뇌 CT/MRI) 진통제(통증 조절)
	일차성	편두통	예방치료
		긴장성 두통	목 스트레칭, 마사지, 스트레스 관리
		군발 두통	예방치료
	이차성	뇌출혈	항고혈압제, 뇌동맥류 지혈, 감압개두술
		뇌수막염	항생제, 항바이러스제, 스테로이드
		뇌종양	PET/CT 수술, 항암제, 방사선
	(안심/진단검사/치료응급/회피교정/검진접종) [안심] 2 차성 두통이 아닌 경우) “다행히 위험한 원인이 있는 것이 아니라 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다” 응급 상황인 경우) “응급 상황일 수 있어, 우선 빠르게 설명을 드리겠습니다” [진단검사치료] -의심되는 질환 설명- 검사: 혈액검사 + 영상검사(뇌출혈이나 감염, 종양에 의한 이차적 두통을 감별하기 위해 시행한다고 말하기) 치료: 진통제 편두통 or 군발두통) 치료에서 예방약물에 대해 교육 - 예방 약물은 1~2 개월 꾸준히 복용해야 효과가 나타남을 설명 [응급] “이런 증상이 나타나면 뇌출혈, 뇌감염, 뇌종양에 의한 것일 수 있으니 최대한 빨리 병원에 와주세요” *영상검사의 적응증(red flag sign) -전신 증상 동반 (체중감소, 심한 발열) -신경학적 증상 동반 (팔다리 힘빠짐, 편측 마비, 구음장애, 의식저하) -이제까지 경험해보지 못한, 갑작스럽게 발생한 심한 두통 -특정 자세에서 심해지거나, 완화되는 두통 -50 세 이후에 새롭게 발생한, 혹은 점점 심해지는 두통 [회피/교정] 일차두통과 만성두통의 관리 교육 -약물 남용에 대해 교육: “약물을 너무 많이 드시면 약효과도 떨어질뿐더러 두통이 오히려 심해질 수 있고 부작용이 심해지니 증상이 너무 심할때만 한알씩 드세요” -고혈압 조절, 금연 금주를 통해 심뇌혈관 위험도 낮추기		

	-규칙적인 수면 및 식습관 -스트레스 줄이기(두통 유발 요인 피하기) -주기적으로 스트레칭 -커피 먹다가 안먹으면 두통 발생할수도~ 커피 많이 먹을 경우 점진적으로 끊는 것을 권장 [검진/접종]
PPI	궁금하신 점 있으실까요?

아세트아미노펜: 타이레놀, 서스펜, 펜잘, 타이펜, 게보린

엔세이드: 부루펜, 애드빌, 탁센, 낙센, 씨레브렉스